

Narcyzm *wrażliwy*

Wycofany, wstydlivy, depresyjny — ale w głębi przekonany o własnej wyjątkowości i niezrozumieniu przez świat. Często mylony z depresją lub zaburzeniem unikającym (AvPD). Rokuje lepiej niż grandiozyjny.

CZAS: 12 min **Diagnostyka różnicowa** **ŹRÓDŁO:** Pincus & Lukowitsky (2010); Wink (1991); Cain (2008)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz sześć cech narcyzmu wrażliwego (sekcja 01) — co go odróżnia od grandiozyjnego. **2** · Zobaczysz tę samą rdzenną grandiozję, która jest tylko gorzej obroniona (sekcja 02). **3** · Nauczysz się odróżniać narcyzm wrażliwy od depresji i zaburzenia unikającego (sekcja 03) — bo te trzy obrazy wyglądają podobnie z zewnątrz. **4** · Dowiesz się, dlaczego subtyp wrażliwy rokuje *lepiej* w terapii (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Subtyp wrażliwy (ang. *vulnerable / covert narcissism*) różni się od grandiozyjnego **ekspresją, nie rdzeniem** — pacjent jawnie wycofany i wstydlivy, ale wewnętrznie przekonany o własnej wyjątkowości i niezrozumieniu przez świat. Wink (1991) w analizie czynnikowej skal narcyzmu wyodrębnił dwa wymiary: grandiozyjny i wrażliwy. Pincus i wsp. (2009) sformalizowali to psychometrycznie w *Pathological Narcissism Inventory* (PNI). Pincus & Lukowitsky (2010) oraz Cain i wsp. (2008) pokazali, że narcyzm wrażliwy częściej trafia do gabinetu — bo widocznie cierpi: depresja, samotność, izolacja, chroniczny wstyd. **Kluczowe odróżnienie diagnostyczne:** klinicysta widzi pacjenta wycofanego, depresyjnego, samokrytycznego — i diagnozuje depresję albo zaburzenie unikające osobowości (ang. *Avoidant Personality Disorder*, AvPD). Standardowa terapia poznawczo-behawioralna pomaga objawowo, ale ukryta grandiozja i poczucie „niezrozumiałego geniuszu” pozostają. Pacjent wraca po pół roku z nawrotem. **Pytanie różnicujące:** „Czy myślisz czasem, że ludzie nie rozumieją Twojej wyjątkowości?” — odpowiedź „tak” skłania ku narcyzmowi wrażliwemu, nie depresji. Ronningstam (2011) zauważyła, że w terapii oba subtypy *oscylują* — pacjent jawnie grandiozyjny może w sesji ujawnić wrażliwość, a wrażliwy może po latach terapii odkryć grandiozyjne fantazje. Subtyp wrażliwy rokuje **lepiej** w terapii niż grandiozyjny — motywuje go widoczne cierpienie, podczas gdy grandiozyjny przychodzi pod przymusem (rozwód, kryzys zawodowy).

01 Sześć cech narcyzmu wrażliwego

1 · NADWRAŻLIWOŚĆ NA KRYTYKĘ

Reakcja na uwagę: *nie* furia (jak u grandiozyjnego), tylko **wycofanie**. Wyłączenie kontaktu, milczenie, dystans. Tygodniami pracowanie w głowie.

3 · CICHĄ ZAZDROŚĆ

„Powinienem/-am mieć to, co oni.” Niewyrażana otwarcie, tylko skrycie. Czasem agresja pasywna: ironia, lekceważące komentarze, dystans.

5 · UNIKANIE RYWALIZACJI

Wycofanie z konkurencji i sytuacji oceny. Bo przegrana = potwierdzenie defektywności. Lepiej *nie startować*, niż przegrać.

2 · FANTAZJE BEZ DZIAŁANIA

Wewnętrzne wizje wielkości („będę światowej klasy”, „kiedyś się okaże”), ale *bez działania*. Bo działanie = ryzyko porażki, a porażka = katastrofa.

4 · POCZUCIE „NIEROZUMIANEGO GENIUSZU”

„Jestem szczególny/-a, ale nikt tego nie widzi.” Świat nie potrafi docenić. Romantyzowanie samotności i niezrozumienia.

6 · DEPRESJA I PUSTKA

Chroniczne objawy depresyjne, anhedonia, pustka, samokrytycyzm. To często powód przyścia do gabinetu — i powód błędnej diagnozy depresji.

02 ☉ Ten sam rdzeń, słabsza obrona

Pincus & Lukowitsky (2010): subtyp wrażliwy nie ma *mniej* grandiozji — ma **słabsze obrony**. Wstyd częściej przebija się do świadomości. Stąd jawne cierpienie. Ale fantazje wielkościowe i poczucie niezrozumienia są *te same*.

GRANDIOZYJNY

„Jestem najlepszy/-a” — **głośno**. Działa, eksploatuje, dominuje. Obrona *skuteczna* — nie czuje wstydu na co dzień, dopóki ktoś nie zakwestionuje fasady.

WRAŻLIWY

„Powinienem/-am być najlepszy/-a” — **cicho**. Wycofany/-a, depresyjny/-a, zawstydzony/-a. Obrona *nieszczelna* — wstyd i poczucie defektywności są chroniczne.

03 ✎ Różnicowanie — z czym mylić

Trzy obrazy mogą wyglądać podobnie z zewnątrz: **wycofany pacjent z poczuciem niewystarczalności**. Ale rdzeń jest *różny*, a leczenie inne.

DEPRESJA

epizodyczna, bez fantazji wielkości

Anhedonia, smutek, obniżony napęd. *Brak* ukrytej grandiozji. Po remisji epizodu pacjent wraca do typowego siebie.

ZABURZENIE UNIKAJĄCE (AVPD)

lęk przed oceną, bez wyjątkowości

Unikanie z lęku przed odrzuceniem. Pacjent *nie* czuje się wyjątkowy — czuje się zwykły i obawia się oceny. Akceptuje miłość i wsparcie.

NARCYZM WRAŻLIWY

chroniczny, z ukrytą grandiozją

Cierpienie + **poczucie niezrozumianego geniuszu**. Wycofanie nie z lęku, tylko z rezygnacji („świat i tak nie doceni”). Romantyzowanie samotności.

Pytanie diagnostyczne (Pincus 2009): „Czy myślisz czasem, że ludzie nie rozumieją Twojej wyjątkowości / Twojego potencjału / Twojej głębi?” Odpowiedź „tak” plus objawy depresyjne to często NPD wrażliwy. Pacjent *rzadko* opowie o tym spontanicznie — ze wstydu. Trzeba zapytać wprost, normalizując: „wielu pacjentów ma rozdwojone obrazy siebie”.

04 🔍 Rokowanie — subtyp wrażliwy rokuje *lepiej*

CO DAJE PRZEWAGĘ

Motywacja przez cierpienie. Pacjent wrażliwy *czuje*, że coś jest nie tak. Przychodzi do terapii sam, nie pod presją. Aliansja jest łatwiejsza — mniej fasady do przebicia. Ronningstam (2023).

CO WYMAGA DELIKATNOŚCI

Pacjent wrażliwy jest *kruchszy* emocjonalnie. Konfrontacja, którą wytrzyma grandiozyjny, u wrażliwego może wywołać kryzys. Terapeuta musi być **jeszcze delikatniejszy**. Praca ze wstydem (CFT) na pierwszym planie.

Klucz: narcyzm wrażliwy jest **trudniejszy do rozpoznania** — bo wygląda jak depresja, lęk społeczny albo niska samoocena. Kluczowa różnica: *w tle leży poczucie uprzywilejowania i wyjątkowości*, choć ukryte. Pytanie różnicujące o „nierozumianą wyjątkowość” to najszybsza droga do prawdziwej diagnozy (Pincus 2009). Leczenie podobne do grandiozyjnego — terapia schematów, praca ze wstydem (CFT), mentalizacja (MBT) — ale wymaga większej delikatności. Rokowanie *lepsze*: motywacja przez cierpienie zastępuje motywację przez przymus zewnętrzny, którą widzimy u subtypu grandiozyjnego. Ronningstam (2011, 2023): w terapii oba subtypy oscylują — wartość ma *jednoczesna mapa obu wymiarów*, nie kategoriyczny wybór.